

«Сечокам'яна хвороба»

Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- в'яснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку “Симптом Пастернацького”;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар терапевтичного відділення. До Вас звернувся чоловік.

Алгоритм дій здобувача.

	<i>Дії здобувача освіти</i>	<i>Текст стандартизованого пацієнта</i>
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікарка-терапевт, Катерина Іванівна. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження.	Добре
<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Олександр Миколайович
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	36 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Я працюю водієм.
2.ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ):		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
<i>Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»</i>	Олександр Миколайовичу, наша розмова цілком конфіденційна	Добре.
3.ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Олександр Миколайовичу, що Вас турбує?	Нестерпний біль у попереку, часте сечовипускання.
	Опишіть біль у попереку: де болить, кудись віддає?	Болить праворуч, віддає в пахову ділянку.
	Постійний чи приступоподібний біль, після чого проходить?	Приступоподібний. Приймав анальгін, але не допомогло.

	Сечовипускання болюче? Кров у сечі?	Так, сечовипускання болюче. Крові не бачив.
	Температура тіла підвищувалась?	Ні.
<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	Коли у Вас з'явилися скарги?	Все почалося 4 години тому.
	З чим пов'язуєте?	Не знаю. Ми повернулись з дня народження і мене прихватило. Прийняв анальгін, не допомогло. Вирішив не чекати ночі, приїхав до Вас.
	Вживали гостру, жирну їжу, алкогольні напої?	Так, їжа була гострою з прянощами. Алкоголь майже не пив, тільки келих червоного вина.
	Раніше були подібні напади?	Ні.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет? Операції, травми протягом життя?	Ні
	Шкідливі звички?	Ні
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Спадковість: чи хтось у сім'ї хворів хронічними захворюваннями?	Ні
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я Вам перевірю симптом Пастернацького.	Так, зараз.
ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні.		
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА		
Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді		
	Визначення больових відчуттів в поперековій області зліва (лікар кладе свою одну руку на область XII ребра ліворуч від хребта і здійснює що до неї короткі удари другою рукою, стиснутою в кулак).	
	Визначення больових відчуттів	

	в поперековій області справа (лікар кладе свою одну руку на область XII ребра праворуч від хребта і здійснює що до неї короткі удари другою рукою, стиснутою в кулак).	
	Визначити «позитивний» чи «негативний» симптом Пастернацького: симптом Пастернацького позитивний праворуч	Коли здобувач освіти здійснить короткі удари праворуч – сказати «Боляче»
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
<i>Уточнити самопочуття</i>	Як Ви себе відчуваєте, все добре? Одягайтеся.	Так.
<i>Пояснити подальші дії</i>	Олександр Миколайовичу, враховуючи Ваші скарги, раджу Вам подальше обстеження в стаціонарі для встановлення діагнозу і призначення ліків.	
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром – біль в спині	Що робити?
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Спочатку треба відкоригувати дієту: Забороняється червоне м'ясо, оселедець, страви з тельбухами тварин. Не можна холодці, міцні бульйони, кислі рослини (щавель, салат, шпинат). Потрібно відмовитися від маринадів, копченостей, приправ у вигляді хрону, гірчиці, аджики. Протипоказаний алкоголь у будь-якому вигляді. Рекомендується обмежити споживання кальцію та фосфору. Дозволяються свіжі овочі та фрукти, рослинні олії. Не впливають на уrolітиаз борошняні страви, мед, каші та крупи.	Дякую, лікарю
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Олександр Миколайовичу, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозумів
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає

	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.
--	--	--------------------------------